

聴覚の局在、前庭症候群、深頸部、気道

聴覚経路と検査

- 伝音難聴は蝸牛前で音を減衰
- 感音難聴は有毛細胞、神経、中枢
- 気導閾値は両経路を含む
 - 骨導は外耳・中耳を迂回
 - 気骨導差は伝音障害を支持
- 語音弁別不良は神経性を示唆
- 音叉検査は確率を修正
 - 伝音：ウェーバー患側、骨導優位
 - 感音：ウェーバー健側、気導優位
 - 手技や両側病変で誤る

突発性難聴と耳の感染

- 耳垢や鼻づまりと誤認される
 - ステロイド効果は時間依存性
 - 正常耳鏡所見でも良性でない
- 外耳炎は外耳道皮膚に局限
 - 閉塞時は耳用ウィックや清掃
 - 穿孔時アミノグリコシドは内耳毒性
- 突発性難聴と耳の感染
 - 夜間激痛、脳神経障害：頭蓋底骨髄炎
 - 中耳炎は発赤でなく鼓膜膨隆
 - 成人の片側貯留液：上咽頭を調べる
 - 真珠腫は疼痛が軽くても骨を侵食

耳鳴と聴覚機能

- 拍動性か、片側か両側か
- 脈拍同期性は血管性機序
- 非対称難聴を伴う片側：後迷路性評価
- リハビリで苦痛軽減、知覚は残る
- 機能は純音閾値だけで決まらない
- 補聴器は周波数別増幅と両耳入力
- 人工内耳は電気刺激で聴神経へ

深頸部感染と気道危機

- 深頸部感染は筋膜間隙を進展
- 扁桃周囲膿瘍：開口障害、口蓋膨隆
- ルートヴィヒアンギーナは舌を挙上
 - 鎮静で代償性筋緊張が失われる
- 喘鳴の相で閉塞部位を推定
- 重症度は音量でなく呼吸仕事量と疲労
 - 静かな喘鳴は疲弊を意味し得る
- 保たれた酸素飽和度で安心しない
 - 完全閉塞直前に酸素化が急落
- 熟練者、困難気道器具、外科的気道を準備

時間依存性の症候群

- 喘鳴、流涎、急速に拡大する腫脹
- 深頸部敗血症、重症鼻出血
- 突発性感音難聴、中枢徴候を伴うめまい
- 狭い解剖学的空間で急速に進む
 - 気道閉塞、頭蓋内波及、誤嚥

前庭の機序と症候群

- 左右迷路は均衡した安静信号
 - 片側喪失は回転と解釈
- 前庭眼反射は頭と反対へ眼を動かす
 - 補正性サッカード：末梢反射低下
 - 中枢病変では反射が保たれ得る
- 時間経過と誘発因子で分類
 - 数秒、頭位性：良性発作性頭位めまい症
 - 数分から数時間：片頭痛、メニエール、虚血
 - 数日持続：前庭神経炎か脳卒中
 - 「動く」と悪化」は非特異的
- 耳石が半規管へ、耳石置換法
- 減衰しない垂直性眼振：中枢性
- 検査群は持続性症候群でのみ検証
 - 早期後頭蓋窩MRIは偽陰性あり

鼻、副鼻腔、異物

- アレルギー性鼻炎は免疫グロブリンE依存性
- 鼻内ステロイドは定期使用、中隔から外側
- 片側閉塞、血性分泌：腫瘍を疑う
- 薄い眼窩壁と弁のない静脈で波及
 - 緊急画像、静脈抗菌薬、排膿
- 軟骨性鼻翼を圧迫、鼻骨は無効
 - 鼻中隔両面の焼灼で穿孔危険
 - 後方出血は気道と循環を脅かす
- ボタン電池は急速な組織壊死
 - 盲目的摘出は異物を押し込む

発声と声帯麻痺

- 持続嚙声は声帯を可視化
- 反回神経は頭蓋底から胸部まで
 - 甲状腺、肺、大動脈、縦隔疾患
- 両側麻痺は気道を脅かす

嚥下の安全と誤嚥

- 覚醒、喉頭閉鎖、感覚、咳が必要
- 感覚低下で無症候性誤嚥
- 嚥下内視鏡は咽頭と残留を評価
- 嚥下造影は運動と代償法を表示
- 安全策は水分や楽しみを損ない得る
- 誤嚥性肺炎は多因子で生じる
 - 絶食でも唾液の誤嚥は残る
 - 口腔ケア、座位、一口量
- 食形態は実物の粘度で共有